

Perfuração de víscera oca · abdome agudo

Perfuração = ar livre + peritonite. Ressuscite, antibiótico de amplo espectro e controle de foco cirúrgico precoce — atraso eleva mortalidade.

Causas clássicas

Lembre - Causas clássicas

Úlcera péptica perforada, diverticulite perforada, apendicite furada, trauma e corpo estranho. Em úlcera, epigastria súbita 'em punhalada' é o clichê.

Fluxo: clínica de peritonite !' Rx/TC com ar livre !' cirurgia de urgência após estabilização.



Conduta perioperatória

- ABC, volume, correção eletrolítica e sonda se íleo
- ATB cobrindo Gram⁺ e anaeróbios (e Gram⁺ conforme protocolo local)
- TC se estável e dúvida; Rx tórax/abdômen pode mostrar pneumoperitônio
- Cirurgia: lavagem, fechamento/resseção e drenagem conforme sítio e contaminação

Sinais de alerta

Achado | Significado

Defesa/rigidez difusa | Peritonite generalizada

Ar sob diafragma | Perfuração oca até prova em contrário

Lactato⁺ / hipotensão | Sepses abdominal — urgência

Imunossuprimido | Clínica pode ser atenuada

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não trate perfuração com 'observação prolongada' se há peritonite difusa. Antibiótico isolado não substitui controle de foco. Em úlcera, lembrar *Helicobacter* no follow-up — mas a urgência é cirúrgica.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1